EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR COMPLEMENTARIO

Elemento	Descripción
Indicador de Evaluación	Control óptimo de la presión arterial en personas con hipertensión (HT).
Indicador Complementario	Control óptimo de presión arterial en personas con hipertensión (HT), según grupo de edad y sexo (V-2.0)
Definición conceptual	Corresponde al porcentaje de personas según grupo de edad y sexo atendidas por HT (código diagnóstico CIE-10: I10x), y presentan cifras óptimas de presión arterial (PA) en el periodo (parámetros abajo indicados). Las cifras óptimas de presión arterial se alcanzan cuando los valores de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD), cumplen los siguientes parámetros: • Personas de 20 a 84 años, con Bajo/Moderado riesgo cardiovascular, cuya PAS es <140 y PAD menor a 90 (mmHg). • Personas de 20 años y más, con Diabetes Mellitus ó Enfermedad Renal Crónica ó Cardiopatía Isquémica ó Alto riesgo cardiovascular, cuya PAS es <130 y PAD menor a 80 (mmHg). • Personas de 85 y más años sin Diabetes Mellitus ó Enfermedad Renal Crónica, ó Cardiopatía isquémica ó Alto Riesgo Cardiovascular, cuya PAS es <140 y PAD menor a 90 (mmHg). (Protocolo de atención clínica para la persona adulta y adulta mayor con presión arterial elevada e hipertensión arterial en el primer nivel de atención de la CCSS, 2025) <u>Definiciones:</u> <u>Cifras óptimas de presión arterial (PA):</u> Valores menores a los limites superiores de presión arterial sistólica y diastólica (que han demostrado no aumentar el riesgo cardiovascular de las personas con HT), según las guías de manejo de personas con esta patología. <u>Puesto de Visita Periódica (PVP):</u> Edificación ubicada en localidades con problemas de accesibilidad geográfica o funcional: donde en forma periódica, un EBAIS se traslada desde la sede del área o de ebáis para brindar los servicios de atención integral en salud a la población. Incluye: • Consultas de primera vez de personas de los grupos de edad de 20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más. Sexo Masculino y Femenino con diagnóstico de HT en el periodo. • Última consulta con registro de PA en personas de los grupos de edad de 20 a 39, 40 a 64, 20 a 64 y 65 años y más. Sexo Masculino y Femenino con diagnóstico de HT, en el periodo. Excluye: • Cifras de PA inconsistentes (PAS< 50 mmHg, PAD < 40 mmHg).

	• Consultas sin registro de PA; que son realizadas en puestos de visita periódica y que no cuentan con Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES). • Personas de 20 años y más sin registro de: Peso y Talla (para cálculo de IMC) y registro de Fumado (SI/NO), realizadas en puestos de visita periódica que no cuentan con SIES.	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas con HT según grupo de edad y sexo, con últimas cifras de PA óptimas, en el periodo. • Número de personas según grupo de edad y sexo, con atención por HT en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas con HT según grupo de edad y sexo, con últimas cifras de PA óptimas en el periodo}}{\text{Número de personas según grupo de edad y sexo, con atención por HT en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	• Prevención • Tratamiento
	Temática	Enfermedades Crónicas No Transmisibles-HT
Línea base	Se define con los resultados de la EPSS 2025	
Periodicidad	Quinquenal: en construcción	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Reporte de HT y Cubo Cardiovascular): • Atenciones realizadas y cifras de presión arterial.	
Clasificación	Indicador de Resultado	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo) • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	Se realiza el diseño y evaluación con la normativa y los recursos institucionales existentes. Se podrán realizar actualizaciones y cambios a esta ficha técnica si ocurren modificaciones en alguna de estas.	